

ΟΠΙΟΕΙΔΗ – ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

Γενικά: Στα οπιοειδή περιλαμβάνονται οι εξής ουσίες: Μορφίνη, Μεπεριδίνη (*Πεθιδίνη*), Ηρωίνη, Κωδεΐνη, Οξυκωδόνη, Υδροκωδόνη, Βουπρενορφίνη, Φεντανύλη, Απομορφίνη, Μεθαδόνη, Ναλμπουφίνη, Πενταζοκίνη, Προποξυφαίνη, Τραμαδόλη, Ταπενταδόλη, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής πιθανώς να παρουσιαστεί σε κώμα, με **έντονη μύση** των κορών δίκην κεφαλής καρφίτσας (*εκτός της Τραμαδόλης και Πεθιδίνης που προκαλούν μυδρίαση*), με αναλγησία (μη ανταπόκριση) στα επώδυνα ερεθίσματα και καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας, λόγω μείωσης της ευαισθησίας του εγκεφαλικού στελέχους στα επίπεδα CO₂.

Τα οπιοειδή προκαλούν καταστολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) και έτσι μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία (*εκτός της Πεθιδίνης*), βραδύπνοια (*με βαθιές αναπνοές*), βρογχόσπασμος, υπόταση, ναυτία και έμετοι, ξηρότητα στόματος, εμβοές ότων, εξάνθημα (*από την έκλυση ισταμίνης*), μυική δυσκαμψία, μειωμένη κινητικότητα του εντέρου (*ειλεός*), κατακράτηση ούρων ή ολιγουρία, υπνηλία ή λήθαργος που μπορεί να καταλήξει σε κώμα.

Η Τραμαδόλη, η Πεθιδίνη και η Προποξυφαίνη μπορεί να προκαλέσουν σπασμούς.

Διαφορική διάγνωση: Κωματώδης ασθενής με μύση μπορεί να εμφανιστεί μετά από χρήση αντιψυχωσικών (*Αλοπεριδόλη, Ρισπεριδόνη, Ολανζαπίνη, Κουετιαπίνη, κ.ά.*), Μιτραζαπίνης, Κλονιδίνης, Ονδασεντρόνης, σε δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικά, σε χρήση κολλυρίων Πιλοκαρπίνης ή Προσταγλανδινών (PGAs), σε αιμορραγικά ΑΕΕ στην περιοχή της γέφυρας.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Αξιολογούμε πρωτίστως τα Α-Β-С-D-Ε του ασθενούς. Αν ο ασθενής είναι απνοϊκός και δεν ανανήφει μετά την 1^η ή τη 2^η δόση αντιδότη, τότε πρέπει να διασωληνωθεί άμεσα.
2. Χορηγούμε οξυγόνο σε υψηλές ροές (ήτοι 8-12 lt/min O₂) με μάσκα Ambu ή με μάσκα Venturi (31-40 %), έως ότου ετοιμάσουμε τα φάρμακα και τα αντιδότες προς χορήγηση.
3. Εφόσον η λήψη της τοξικής ουσίας έχει γίνει από το στόμα, προ 4-6 ωρών, επιβάλλεται η πρόκληση εμέτου. Χορηγείται σιρόπι Ιπεκακουάνας (*syr. Ipecacuan 30 ml για ενήλικες και 15 ml για παιδιά*) μαζί με 2-3 ποτήρια νερό. Εάν δεν προκληθεί έμετος επαναλαμβάνεται η ίδια δόση, μία ακόμη φορά, μετά από 15 λεπτά. Αν ο ασθενής βρίσκεται σε λήθαργο ή κώμα ή εμφανίζει σπασμούς, τότε η πρόκληση εμέτου έχει απόλυτη αντένδειξη.
4. Μετά τον έμετο εκτελούμε εκπλύσεις στομάχου μέσω ρινογαστρικού καθετήρα Levin και στη συνέχεια χορηγούμε **ενεργό άνθρακα** 30-50 gr (Toxicarb) σε νερό μέσω του Levin.

5. Η Ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής των μ, δ, και κ υποδοχέων των οπιοειδών και μπορεί να δοθεί ενδοφλέβια, ενδοοστικά, ενδομυϊκά, υποδόρια και ενδοτραχειακά. Προλαμβάνει και αντιστρέφει τις επιδράσεις της υπερδοσολογίας των φυσικών και συνθετικών οπιοειδών, όπως είναι η αναπνευστική καταστολή, η καταστολή του ΚΝΣ και η υπόταση.

Χορηγούμε **Ναλοξόνη** 0,4-2 mg (ήτοι 1-5 amp. Narcan) iv-bolus, (σπανίως im ή sc).

Ενδοφλέβια χορήγηση 1 mg ναλοξόνης (2½ amp) ανταγωνίζεται τη δράση 25 mg ηρωίνης.

Επί μη βελτίωσης, επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση 2-5 amp. Naloxone ανά 3-5 λεπτά, για άλλες 3 φορές. Η ενδοφλέβια χορήγηση θεωρείται η πλέον αξιόπιστη κι αποτελεσματική, ενώ μπορούν να χορηγηθούν έως και 12 amp. (δηλαδή 4,8 mg) Naloxone (Narcan 0,4 mg) σε 1000 ml N/S με αργό ρυθμό χορήγησης εντός 12ώρου (0,4 mg/h, δηλαδή 1 amp/h), ιδίως επί τοξίκωσης από μακράς δράσης οπιοειδή (*Μεθαδόνη, Φεντανύλη, Τραμαδόλη*).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που ο ασθενής (*όντας χρόνιος χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών*) εκδηλώσει **στερητικό σύνδρομο** στη διάρκεια αντιμετώπισης της δηλητηρίασεως. Για αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τιτλοποίηση της δόσης της Ναλοξόνης. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες της Ναλοξόνης είναι, η υπόταση, αρρυθμίες, μη καρδιογενές οξύ πνευμονικό οίδημα, ζάλη, τρόμος, επιληπτική κρίση, κ.ά.

6. Άμεση διακομίδη στο νοσοκομείο, εφόσον ο ασθενής δεν συνέρχεται ή επιδεινώνεται.